

Uważność w dystansie

Myśl o chorobie przychodzi. Pacjent zazwyczaj angażuje. Tutaj — zauważa i odpuszcza. Bez analizowania, bez walki.

CZAS: 5–10 min, 2× dziennie 6–8 tyg. praktyki

ŹRÓDŁO: Wells (2009); Bailey & Wells (2015); Capobianco & Nordahl (2023)

JAK UŻYWAĆ

Gdy pojawi się myśl o chorobie („a może to guz?”), zastosuj sekwencję: **zauważ** → **nazwij** → **odpuść**. Nie analizuj, nie kwestionuj, nie szukaj odpowiedzi. Wracaj do tego, co robieś/-aś. 5–10 min wieczornej praktyki + użycie w ciągu dnia, gdy myśl wraca.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W modelu metakognitywnym Wellsa (ang. *Metacognitive Therapy*, MCT 2009): problem nie jest w *treści* myśli o chorobie, tylko w **angażowaniu się** w nie (przeżywanie, analizowanie, sprawdzanie). Uważność w dystansie (ang. *detached mindfulness*) to *nowy sposób reagowania* na myśli — nie eliminacja ich. Skuteczność MCT w lęku zdrowotnym: $g = 0.94$ dla redukcji objawów (Capobianco & Nordahl, 2023, meta-analiza). $NNT \approx 3$.

01 ? Co to NIE jest — uniknij 4 pomyłek

NIE JEST TŁUMIENIEM

„Muszę przestać myśleć o raku” → myśl wraca silniejsza (efekt białego niedźwiedzia, Wegner 1987). Cel: *pozwolić myśli być*, nie usuwać.

NIE JEST ANALIZĄ

„Czy to jest racjonalna myśl? Sprawdzę dowody...” → wpadasz w analizowanie. *Detached mindfulness* ≠ *restrukturyzacja*.

NIE JEST ROZLUŻNIENIEM

Nie chodzi o spokojny stan ciała. Lęk może zostać, mięśnie napięte — to nieistotne. Liczy się *relacja z myślą*.

NIE JEST POZYTYWNYM MYŚLENIEM

„Wszystko będzie dobrze, jestem zdrowy/-a” → to jest *walka*. Cel: *nic nie robić* z myślą, nie próbować ją zastąpić.

02 ? Trzy kroki — sekwencja

1

ZAUWAŻ

„Pojawiła się myśl, że może coś mi jest.” *Bez oceny*, bez „znowu”. Po prostu zauważ obecność.

2

NAZWIJ

„To jest myśl o zdrowiu.” Słowo „myśl” tworzy dystans — to *etykietowanie*, nie analizowanie treści.

3

ODPUŚĆ

Wracaj do tego, co robisz. Myśl może *zostać w tle* — nie szkodzi. Liczy się to, że nie podążasz za nią.

03 Pięć metafor — która do mnie trafia?

MCT używa metafor, bo pomagają poczuć właściwą relację z myślą. Przeczytaj wszystkie i zaznacz tę, która do Ciebie trafia najbardziej.

☐ 1 · CHMURY

Myśli to chmury na niebie. Niebo (świadomość) zostaje. Chmury *przepływają*. Nie chwytasz ich.

☐ 2 · POCIĄG

Myśli to pociągi przyjeżdżające na peron. Patrzysz, jak wjeżdżają i odjeżdżają. *Nie wsiadasz*.

☐ 3 · HAŁAŚLIWI SĄSIEDZI

Myśli to sąsiedzi za ścianą. Słyszysz ich, ale nie idziesz spierać się. *Żyjesz swoim życiem*, mimo hałasu.

☐ 4 · RADIO W TŁE

Myśli to radio. Może grać. *Nie musisz słuchać* — uwaga jest gdzie indziej. Tło, nie pierwszy plan.

☐ 5 · LIŚCIE NA RZECIE

Wyobraź sobie rzekę. Każdą myśl *kładziesz* na liściu i pozwalasz odpłynąć. Nie pchasz, nie zatrzymujesz — po prostu obserwujesz, jak płynie. Klasyk z ACT (Hayes 2004), używany też w MCT.

04 Dziennik — tydzień praktyki

5–10 min rano lub wieczorem: usiądź, obserwuj przepływ myśli (nie tylko o zdrowiu — wszystkich). Dodatkowo w ciągu dnia: gdy złapiesz się na angażowaniu w myśl o chorobie — zauważ-nazwij-odpuść.

DZ.	PRAKTYKA <i>min</i>	ZŁAPAĆ I ODPUSZCIĆ <i>ile razy w ciągu dnia</i>	ŁATWOŚĆ <i>0–10</i>	OBSERWACJA
<i>Pn</i>				
<i>Wt</i>				
<i>Śr</i>				
<i>Cz</i>				
<i>Pt</i>				
<i>Sb</i>				
<i>Nd</i>				

Klucz: uważność w dystansie to *nawyk uwagowy*, nie technika do napadu. Pierwsze 2 tygodnie wydają się „za proste, żeby działały”. Po 4–6 tygodniach efekt jest mierzalny: HAI spada średnio o 10–14 pkt (Bailey & Wells, 2015). Cel końcowy: myśli o chorobie pojawiają się **tak samo**, ale przestają zatrzymywać Cię w pętli sprawdzania.